

Опыт хирургического лечения обтурационной толстокишечной непроходимости опухолевого происхождения

Тимашиова Е.В.

Алматы, Республика Казахстан

Обтурационная кишечная непроходимость является одним из наиболее частых и тяжелых осложнений рака толстой кишки. По данным большинства авторов частота ее колеблется от 30 до 76,8%. По данным А. Е. Богданова и С. В. Силуянова, в правой половине толстой кишки опухоли располагаются в 19,3 % случаев, в поперечной ободочной - в 5,3 %, в левой половине - в 50,8 % и в прямой кишке - у 24,6 % больных.

С ростом урбанизации и значительной миграцией населения количество таких больных значительно возросло, при этом последние поступают в стационары уже в стадии декомпенсации и ими вынуждены заниматься хирурги общего профиля. Кроме того, только единичные пациенты поступают в хирургический стационар в первые сутки после начала заболевания, подавляющее большинство (60-90%) – в сроки более 3-х суток.

Среди госпитализированных по поводу острой обтурационной толстокишечной непроходимости пациенты старше 60 лет составляют 80-90%. Отягощенность сопутствующей сердечно-сосудистой и дыхательной патологией у этой категории лиц достигает 100%. Все перечисленное обуславливает высокую послеоперационную летальность при острой кишечной непроходимости. Основной задачей в хирургическом лечении острой толстокишечной обтурационной кишечной непроходимости опухолевого генеза является устранение явлений кишечной непроходимости и восстановление пассажа кишечного химуса.

При этом проблема хирургического лечения в данной группе больных, при довольно-таки значительном опыте, остается на сегодняшний день актуальной.

За последние 6 месяцев нами анализирована группа из 13 больных с классической картиной острой обтурационной левосторонней толстокишечной непроходимости, которые подверглись хирургическому лечению в экстренном порядке. Все больные были нами предварительно обследованы и подвергнуты оперативному лечению. Выбор объема оперативного вмешательства зависел от тяжести состояния больного (обусловлена возрастом, сопутствующей патологией), локализацией новообразования и его резектабельностью. Небольшие размеры опухолей и сравнительно раннее развитие явлений непроходимости объясняло то, что большинство из них были резектабельными, отсутствовали отдаленные метастазы. Однако, из-за тяжести состояния в 3 случаях операция была завершена наложением разгрузочных колостом (из них только в 1 случае имелись парааортальные метастазы и метастазы в печень), а в 10 случаях – радикальной резекцией опухоли. Тем не менее, среди всех оперированных нами пациентов летальных исходов не было.

При этом в тактике ведения данной группы больных мы придерживались определенных алгоритмов действий, которыми в данной публикации хотелось бы поделиться:

1. Жалобы, анамнез.
2. Физикальные обследования (осмотр, пальпация, перкуссия, аускультация, ректальный осмотр).

Ісікпен байланысты тоқ ішектің обтурациялық бітелуін хирургиялық емдеудегі тәжірибелер.

Тимашиова Е.В.

Алматы, Қазақстан Республикасы.

Тоқ ішектің обтурациясымен ауыратын науқастарды хирургиялық жолмен емдеу әліде актуалды мәселе болып тұр. Мақалада жедел хирургиялық кейінгі 13 науқастың анализі көрсетілген. Автормен айтылған патологияны емдеуде қанағаттанарлық жетістікке жетудегі хирургтың тәсілі алгоритммен көрсетілген. Тоқ ішектің обтурациясымен ауыратын науқастарға жедел хирургиялық көмек ұйымдасқан диагностика және дайындықпен жүргізілуі тиіс.

3. Лабораторные методы исследования: общий анализ крови, гематокрит, общий анализ мочи, группа и резус-фактор крови, билирубин, креатинин, мочевины, глюкоза, коагулограмма.
4. Инструментальные методы исследования: обзорная рентгенография грудной клетки и брюшной полости, УЗИ брюшной полости, ЭКГ.
5. Установка назогастрального зонда и очистительная клизма.
6. Предоперационная инфузионная и симптоматическая терапия.
7. Обязательная антибиотикопрофилактика (использовались препараты широкого спектра действия – цефтриаксон, абактал).
8. Непосредственное хирургическое лечение.
9. В послеоперационном периоде – профилактика тромбоэмболических осложнений (использовался клексан в дозировке 20 мг), эластическое бинтование нижних конечностей.
10. Направление пациента для дальнейшего наблюдения и лечения к онкологу по месту жительства.

Таким образом, неотложная хирургическая помощь больным с обтурационной толстокишечной непроходимостью должна осуществляться при четкой организации диагностики и подготовки больного, при этом не всегда следует стремиться к выполнению радикального оперативного вмешательства, особенно при локализации опухолевого процесса в левой половине ободочной кишки.

Список использованной литературы

1. Абеуевич А.И., Овчинников В.А., Серопян Г.А. // Хирургия. — 2004. — N 4. — С.46
2. Быков А. С. К оценке хирургической тактики при обтурационной толстокишечной непроходимости : диссертация ... кандидата медицинских наук : 1- Ярославль, 2009. - 151 с.
3. Помазкин В. И., Мансуров Ю. В. // Хирургия. — 2008. — № 9. — С. 15—18.
4. Dumont F., Vibert E. et al. // Ann. Chir. — 2005. — Vol. 130, N 6—7. — P. 391—399.